ENFERMERÍA

Tecnologías De La Información Y La Comunicación Tics

NOMBRE DEL PROYECTO

Evaluación y fortalecimiento del conocimiento en primeros auxilios básicos en estudiantes de 3.º año de Bachillerato de la Unidad Educativa Simón Bolívar.

AUTORES:

Angamarca Aguirre Ingrid Margarita

Maldonado Montalvo Erminia Lisseth

Martinez Delgado Diana Lceth

DOCENTE

Mgtr. Carla Raza

OCTUBRE 2025 – MARZO 2026

INTRODUCCIÓN

Los primeros Auxilios son técnicas y medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas para salvarles la vida, hasta disponer de un tratamiento especializado; pero no son un tratamiento médico. Se caracterizan por ser prestados en el lugar del accidente, de forma inmediata o lo más rápido posible, pero sobre todo utilizando únicamente los elementos que se tengan alrededor.

En el presente proyecto ahondaremos en la importancia de conocer los primeros auxilios básicos, que son los cuidados o la ayuda inmediata temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta que llegue algún personal de las ciencias de la salud que se encargará, solo en caso necesario, del traslado a un hospital, tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. Si bien el tema de primeros auxilios básicos es de gran amplitud, saber sobre ellos trae muchos beneficios para la salud humana. Al analizar diversos casos en la vida cotidiana sobre este tema podemos adquirir conocimientos que nos permitan responder las siguientes interrogantes: cuáles son sus objetivos, en qué consisten, cómo se clasifican, cuáles son sus etapas, qué métodos o técnicas podemos realizar frente a cada situación de emergencia que se nos presente, para así saber actuar de inmediato y salvar la vida humana. Consideramos que los primeros auxilios son la atención adecuada y eficaz a una persona afectada, así como la cooperación y las medidas correctas que se toman de manera rápida por la primera persona que se encuentra en el lugar en que se manifiesta la situación de emergencia.

Nos enfocaremos en los principios de los primeros auxilios básicos que es muy común en el presente de la vida de las personas.

Los traumatismos constituyen una de las principales razones por las cuales los padres acuden con sus hijos durante la primera infancia en busca de atención médica. Los traumatismos por mordeduras caninas pueden ocurrir a cualquier edad, aproximadamente un 60% de las víctimas son niños, frecuentes cuando están indefensos, entre los 0 y 5 años y su mayor incidencia se presenta en los grupos de edades entre 2 a 4 y 8 a 10 años y es mayor en varones que en hembras a razón. A causa de su estatura las lesiones típicas ocurren en cabeza, cara y cuello, pudiendo causar marcas serias y permanentes que dejan cicatrices de por vida, como se ha descrito en múltiples estudios, además de un terror psicológico hacia los animales e inclusive llevarlos a la muerte. Las lesiones ocasionadas por mordidas de animales pueden evolucionar desde enrojecimiento e inflamación de las heridas hasta inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, sudoración, escalofríos. Se han reportado síntomas similares a los procesos gripales; lesiones más severas con amputaciones parciales o totales de nariz, orejas, labios, párpados, incluyendo lesiones vasculares, nerviosas y óseas. Con alto riesgo de contaminación bacteriana, pudiendo llegar a situaciones más complejas con sepsis, que demandan definitivamente el manejo con medicación antimicrobiana. Sumado a esto, los riesgos de contraer infecciones virales como la rabia, causada por un virus neurotrópico hallado a menudo en la saliva de los animales infectados.

Por otro lado, tenemos la hipertérmica que es un trastorno de la regulación de la temperatura corporal que se caracteriza por una elevación de la temperatura central superior a 38.3°C. Independientemente de los factores etiológicos, ya sea por un exceso en la producción de calor, o por un defecto en la pérdida de este, se produce un aumento de la temperatura corporal que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de termorregulación del organismo (37,38). Puede

presentarse con sudoración, sofoco, taquicardia, fatiga, mareo, dolor de cabeza y parestesias, progresando a hipotensión, síncope, confusión, delirio, convulsiones y coma. Los cambios en el estado mental y la temperatura central distinguen el golpe de calor potencialmente fatal del agotamiento por calor. Para entender el mecanismo inflamatorio de la fiebre se debe considerar el papel fundamental que cumple el sistema inmunitario, principalmente los macrófagos que, al fagocitar partículas exógenas, ya sean bacterias, virus o toxinas, producen citocinas, las cuales son péptidos de señalización que median las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y una de sus funciones es proteger contra lesiones, es de suma relevancia conocer los factores que afectan la integridad cutánea. las heridas y cortes son lesiones ocasionadas por traumatismo mecánico en las que se observa rotura o interrupción de la continuidad de los tejidos blandos, el proceso reparativo de las heridas puede ser dividido en tres fases: inflamatoria, proliferativa y de reparación tisular y fase de remodelación de la cicatriz, las suturas son los materiales más utilizados en el cierre de heridas, el propósito de la sutura es favorecer y mejorar la cicatrización, la anestesia local es un bloqueo en la conducción nerviosa de forma específica, temporal y reversible, que no afecta a la conciencia, son agentes farmacológicos que producen bloqueo de transmisión de los nervios lo cual nos permite la reparación de la heridas sin causa de dolor en el paciente que la sufre, y para ello usamos materiales de sutura y técnicas adecuadas para cada tipo de herida.

El atragantamiento por cuerpo extraño es una situación clínica producida por la impactación del bolo alimenticio en el estrecho hipofaríngeo y la encrucijada faringolaríngea. El enclavamiento del bolo es capaz de producir obstrucción total de la vía aérea, generando asfixia y

muerte súbita de la víctima si no se resuelve de inmediato. Es más frecuente en el adulto, o por cualquier objeto, también en niños pequeños, para desencajar y aflojar el cuerpo extraño, que luego tenía que ser expulsado mediante la tos. Aparece también en la monografía de Gross, la mini traqueotomía, coniotomía o cricotirotomía. Consiste en realizar una incisión horizontal de un centímetro de longitud a la altura de la membrana cricotiroidea, para liberar las vías respiratorias.

El proyecto tiene como finalidad analizar y fortalecer el conocimiento sobre los primeros auxilios básicos, destacando su importancia como una intervención inmediata, temporal y no especialicéis ante situaciones de emergencia. Su propósito principal es capacitar a las personas para actuar de manera oportuna, eficaz y responsable, contribuyendo la preservación de la vida, la reducción de complicaciones y la prevención de secuelas físicas y psicológicas hasta la llegada del personal de salud especializado.

Buscamos identificar los principios, objetivos, etapas y técnicas fundamentales de los primeros auxilios, aplicándolos al análisis de casos frecuentes en la vida cotidiana, como los traumatismos por mordeduras de animales y los trastornos por hipertermia, los cuales representan riesgos significativos para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como la infancia. A través de este estudio, se pretende promover una cultura de prevención y respuesta adecuada ante emergencias, fomentando la responsabilidad social y el compromiso con el bienestar individual y colectivo.

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA.

1.1. Planteamiento del problema.

Cuando no se aplican correctamente los primeros auxilios básicos, considero que el principal problema es que la situación de la persona afectada puede empeorar significativamente. Una intervención inadecuada puede provocar lesiones adicionales, aumentar el riesgo de infecciones o incluso poner en peligro la vida del paciente. Además, la falta de conocimientos en primeros auxilios puede retrasar la atención médica adecuada y dificultar la recuperación. Desde mi punto de vista, esto demuestra la importancia de que el personal universitario y la comunidad en general cuenten con una formación básica en primeros auxilios para actuar de manera responsable ante una emergencia.

Tener el conocimiento de los primeros auxilios básicos es muy importante aprender porque podemos acudir inmediatamente a la persona que lo necesite en el momento. Los primeros auxilios los podemos definir como los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser atendidos en un centro asistencial. Es importante que estos conocimientos, sean del dominio de los estudiantes de la carrera de enfermería y que, a su vez, los demuestren y enseñen en la comunidad, para que se le puedan prestar los primeros auxilios de una forma eficiente a la persona que ha sufrido un percance. Es importante aumentar el nivel de preparación y formación en este sentido. Es un quehacer para los próximos años el aporte de nuestra sociedad en la formación integral de los futuros profesionales desde el pregrado, con una educación sólida y actualizada en todas sus áreas que desarrollen los métodos de diagnóstico por y el desarrollo de habilidades para la educación de la comunidad. Después de valorar las diferentes definiciones de primeros auxilios y su

conceptualización, se hace necesario exponer la propuesta de proyecto de primeros auxilios. Esta, favorecerá hacia el conocimiento de la sociedad en su conjunto sobre la importancia de los primeros auxilios. Asimismo, la labor que realizan los estudiantes de enfermería para ayudar a poblaciones rurales y periurbanas.

1.2. Formulación y sistematización del problema.

1.2.1. Formulación.

Los primeros auxilios básicos de enfermería son fundamentales para preservar la vida, prevenir complicaciones y favorecer la recuperación del paciente ante situaciones de emergencia. En muchos casos, la atención inmediata que brinda el personal de enfermería marca la diferencia entre una evolución favorable o el agravamiento del estado de salud. Sin embargo, no siempre se cuenta con la preparación teórica y práctica necesaria para actuar de manera correcta y oportuna. Por ello, se plantea la necesidad de analizar el nivel de conocimiento y aplicación de los primeros auxilios básicos en el área de enfermería, con el fin de fortalecer la atención inicial en situaciones críticas.

1.2.2. Sistematización del problema.

La sistematización del problema permite descomponer la problemática principal en aspectos específicos que facilitan su análisis. Para ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Qué nivel de conocimiento poseen los estudiantes o el personal de enfermería sobre los primeros auxilios básicos?
- ¿Cuáles son los procedimientos de primeros auxilios más utilizados ante emergencias frecuentes?

- ¿Qué dificultades se presentan al momento de brindar una atención inmediata y segura?
- ¿Cómo influye la capacitación y actualización continua en la correcta aplicación de los primeros auxilios básicos?
- ¿De qué manera una atención inicial adecuada contribuye a mejorar la evolución del paciente?

1.3. Formulación de objetivos.

1.3.1. Objetivo general.

Evaluar el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios básicos en estudiantes de 3.º año de Bachillerato de la Unidad Educativa Simón Bolívar, con el fin de identificar fortalezas y debilidades en su preparación ante situaciones de emergencia.

1.3.2. Objetivos específicos.

- ✓ Identificar el grado de conocimiento que poseen los estudiantes sobre los protocolos básicos de actuación ante emergencias.
- ✓ Determinar el nivel de comprensión sobre el manejo inicial de situaciones frecuentes como hemorragias, quemaduras, atragantamiento y desmayos.
- ✓ Analizar el conocimiento que tienen los estudiantes sobre la activación del sistema de emergencias y la disponibilidad de recursos básicos como el botiquín.

1.4. Justificación.

La presente investigación y actividad formativa se justifica en la importancia de que los estudiantes cuenten con conocimientos básicos de primeros auxilios, ya que cualquier persona puede enfrentar una situación de emergencia dentro o fuera del entorno educativo. Saber cómo actuar de manera correcta, calmada y segura permite brindar una atención inicial adecuada, evitando complicaciones mientras llega el personal de salud especializado. Capacitar a los compañeros fortalece la prevención, la seguridad y la responsabilidad colectiva ante accidentes.

1.4.1. Justificación teórica.

Desde el punto de vista teórico, este trabajo se fundamenta en los primeros auxilios básicos en enfermería, los cuales establecen que una atención inmediata y correcta puede salvar vidas y reducir riesgos. El conocimiento sobre la identificación de situaciones leves y graves, el manejo inicial de heridas y el uso adecuado del botiquín permite reforzar el aprendizaje teórico adquirido en el área de enfermería. Además, contribuye a consolidar conceptos esenciales que sirven como base para la formación profesional futura.

1.4.2. Justificación práctica.

En el aspecto práctico, esta actividad resulta relevante porque permite a los estudiantes aplicar lo aprendido mediante la práctica directa de maniobras básicas de primeros auxilios. Al capacitar a los compañeros, se promueve la seguridad dentro del entorno educativo y del hogar, ayudando a que todos sepan cómo reaccionar ante un accidente. La práctica de técnicas como la limpieza de heridas, el vendaje y el reconocimiento de situaciones de emergencia brinda mayor confianza y preparación para actuar correctamente en momentos de nervios o estrés.

1.5. Ubicación geográfica.

La investigación se desarrollará en Santa Cecilia en la Cuidad de Lago Agrio, ubicada en la provincia de Sucumbíos, región Amazónica del Ecuador. La zona se caracteriza y particularidades socioeconómicas que influyen en el acceso de servicios de salud y las condiciones de vida de los individuos**.**

Figura 1

Ubicación de la institución Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Nota: Elaborado a partir de (Google Maps, 2026)

1.6. Cronograma de actividades.

N.º	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE TRABAJO GESTIÓN 2026								
		DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO		
		SEMANAS								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Conformación del grupo de trabajo.									
2	Definición de objetivos y marco Teórico.									
3	Diseño y validación de instrumentos									
4	Recolección y análisis de Datos									
5	Redacción del proyecto									
6	Entrega y sustentación									

1.7. Presupuesto.

Ítem	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Taxista	$ 1,50	$ 3,00
2	Hojas Bond	$ 2,00	$ 2,00
3	Copias	$ 1,20	$ 2,40
4	Marcadores (azul, rojo, negro)	$ 1,00	$ 2,00
5	Moto taxi	$ 1,00	$ 3,00
6	Agua	$ 0,50	$ 1,00
7	Bus	$ 0,35	$ 0,70
8	Galletas	$ 0,50	$ 0,50
TOTAL			$ 14,60

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

2.1. Marco teórico

Los Primeros Auxilios vienen siendo un conocimiento de vital importancia, dentro de la vida diaria a nivel general sin discriminar educación, formación académica, extracto social, raza o cultura ya que no es una materia o conocimiento exclusivo del personal de salud, con una capacitación y conocimientos básicos se puede llegar a salvar la vida de un ser humano en caso de ser requerida, a lo largo de la historia se ha ido identificando la necesidad de implementar los Primeros Auxilios, dentro de las mallas curriculares de las carreras de educación superior, con el propósito de mitigar posibles eventos que amenacen la vida de una persona con esto el futuro profesional en cualquier ámbito de desempeño sabrá cómo responder ante una situación de emergencia y podrá darse cuenta que con una acción tan pequeña que éste la realice, hará una marcada diferencia entre la vida y la muerte, las buenas intenciones no salvan vidas la capacitación constante sí. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "un accidente es un acontecimiento, independientemente de la voluntad humana, que pueda alcanzar o no a una persona, y que origina que la persona tenga que solicitar posteriormente asistencia médica, independientemente del daño corporal o mental. (Rodríguez Lorenzo et al., 2020)

Dentro de los primeros auxilios es necesario reconocer que los métodos aplicados varían de acuerdo con la edad y condición en la que se encuentre la persona. En este contexto, Estrada, Gutiérrez & Hernández (2017), refieren que existen métodos como la reanimación cardio respiratoria, que debe ser aplicada con conocimientos técnicos previos para no generar mayor daño. Frente a la diversidad de causales y consecuencias, es importante que el profesional esté

preparado para atender cualquier tipo de acontecimiento que implique poner en marcha un protocolo básico de primeros auxilios, saber cómo actuar ante cada tipo de emergencia debería convertirse en la base primordial de la formación profesional de los estudiantes, Martín (2015) refiere que la solución inmediata ante un accidente son los primeros auxilios.(Teresa Murillo Loján et al., 2021)

El funcionamiento del Ecuador el Servicio Integrado de Seguridad y Emergencias ECU-911 tiene como finalidad dar respuesta inmediata y coordinada ante desastres naturales o antrópicos, la delincuencia común y la atención de emergencias en salud, con una infraestructura tecnológica que permite atender las 24 horas, los 365 días. Hablar de Atención de emergencias, significa referirse a atención prehospitalaria, es decir a los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del hospital, constituyéndose una prolongación del tratamiento de urgencias hospitalarias. En esta visión, el tema Atención de emergencias realiza un acercamiento a los conceptos generales y especializados de emergencia y urgencia, y atención prehospitalaria de emergencias, todo ello en el contexto de la intensa actividad del ECU-911, de esta manera se ofrece una descripción global y a la vez pormenorizada de cada una de las acciones que configuran el quehacer del ECU 911.

2.2. Marco conceptual

Primeros Auxilios: Medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. Su objetivo es aliviar el dolor, la ansiedad del herido y evitar el agravamiento de su estado.

Atención Prehospitalaria: Servicio de salud que se presta a pacientes con enfermedades o accidentes fuera del hospital, constituyéndose en una prolongación del tratamiento de urgencias hospitalarias para garantizar la supervivencia.

Emergencia Médica: Situación de salud que se presenta repentinamente, requiere tratamiento inmediato o atención hospitalaria y conlleva un riesgo alto sobre la vida, la integridad física o la salud del individuo.

Accidente: Acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza externa rápida, que puede alcanzar a una persona y originar la necesidad de asistencia médica, independientemente del daño corporal o mental.

Signos Vitales: Parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones). Incluyen la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Método técnico aplicado con conocimientos previos para mantener la función cardíaca y respiratoria en una víctima de paro, con el fin de no generar mayor daño y preservar la vida.

Servicio Integrado de Seguridad (ECU-911): Institución encargada de dar respuesta inmediata y coordinada ante desastres naturales, emergencias de salud o delincuencia, utilizando infraestructura tecnológica disponible las 24 horas.

Bioseguridad en Primeros Auxilios: Conjunto de medidas preventivas que debe adoptar el auxiliador (como el uso de guantes o mascarilla) para proteger su salud y la de la víctima frente a riesgos biológicos.

Cadena de Supervivencia: Serie de pasos ordenados (reconocimiento, llamada al 911, RCP precoz, desfibrilación y cuidados post-paro) que aumentan las probabilidades de supervivencia de una persona tras un paro cardíaco.

Atragantamiento: Es la obstrucción de la vía aérea por un objeto sólido (alimento, juguete u otros cuerpos extraños) que impide el paso del aire hacia los pulmones, provocando asfixia. Esta situación requiere una respuesta inmediata mediante métodos como la reanimación o maniobras de desobstrucción para evitar daños mayores

Mordeduras de caninos: Son lesiones producidas por la dentadura de un perro que pueden variar desde rasguños superficiales hasta desgarros profundos de tejido, fracturas o amputaciones. El principal riesgo de estas heridas es la infección, debido a la gran cantidad de bacterias presentes en la saliva del animal, y la posible transmisión del virus de la rabia. En primeros auxilios, el protocolo inicial exige el lavado exhaustivo con agua y jabón, el control de la hemorragia y la evaluación médica inmediata para determinar la necesidad de profilaxis (vacunas).

Hipertermia: Se define como el aumento patológico de la temperatura corporal por encima de los niveles normales (generalmente superior a 39°C o 40°C), debido a que los mecanismos de termorregulación del cuerpo se ven superados por la exposición al calor ambiental o al esfuerzo físico extremo. A diferencia de la fiebre, no es una respuesta del sistema inmunológico, sino una acumulación de calor que, si no se trata a tiempo mediante el enfriamiento externo, puede derivar en un golpe de calor, poniendo en grave riesgo la vida del paciente.

Traumatismo: Lesión o daño físico causado en el cuerpo por una fuerza o agente externo, como golpes, caídas o accidentes de tránsito. Su atención requiere inmovilización para no generar mayor daño en la columna o extremidades.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque busca identificar y analizar el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios básicos en los estudiantes de enfermería, sin manipular variables, describiendo la situación tal como se presenta en la realidad.

Al mismo tiempo, posee un enfoque cuantitativo, ya que se recolectarán datos mediante una encuesta estructurada con preguntas cerradas, cuyos resultados podrán ser medidos, tabulados y analizados estadísticamente para determinar el grado de conocimiento de los participantes.

También se considera una investigación aplicada, debido a que pretende generar acciones concretas como realizar una capacitación en primeros auxilios, para mejorar la preparación ante emergencias.

3.2. Diseño de investigación.

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se manipulan variables ni se interviene en las condiciones del estudio; únicamente se observa y analiza el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios básicos en los participantes.

Además, es de tipo transversal, porque la información se recolectará en un solo momento mediante la aplicación de una encuesta, permitiendo obtener una visión del estado actual del conocimiento en el grupo estudiado.

3.3. Población y muestra.

Población: La investigación de este estudio para el presente proyecto está constituido por la cohorte de estudiantes matriculados en el primer semestre de la institución Pontificia Universidad Católica del Ecuador ¨Sede Amazonas'. Se ha seleccionado este grupo poblacional debido a que representan un segmento que inicia su formación académica y, por ende, es el momento idóneo para fomentar una cultura de prevención y respuesta inmediata ante emergencias médicas dentro del entorno universitario.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde los parámetros considerados son:

- n: Tamaño de la muestra.
- N: Tamaño de la población total.
- Z: Nivel de confianza (ej. 95% = 1.96).
- e: Margen de error aceptado (ej. 0.05).
- p: Variabilidad positiva (probabilidad de éxito, a menudo 0.5).
- q: Variabilidad negativa (1 - p).

Muestra: Para la ejecución práctica y recolección de datos, se ha determinado una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 30 individuos pertenecientes a dicho nivel. Este tamaño de muestra permite un manejo didáctico personalizado, garantizando que la transferencia de conocimientos sobre maniobras de auxilio sea supervisada rigurosamente para asegurar la calidad de la técnica en cada participante.

3.4. Desarrollo del proyecto a presentar

La ejecución de este proyecto se estructuró bajo una metodología teórico-práctica, fundamentada en los protocolos internacionales de actuación ante emergencias. El desarrollo se desglosó en las siguientes fases:

Fase I: Diagnóstico y Fundamentación Técnica Se inició con una revisión bibliográfica para establecer los pilares teóricos basados en las directrices de la *American Heart Association* [AHA] (2020), las cuales dictan los estándares globales para el soporte vital. El enfoque se centró en la identificación temprana de situaciones de riesgo y la activación inmediata de la cadena de supervivencia, asegurando que el primer interviniente comprenda su rol crucial en la reducción de la morbimortalidad (Pérez et al., 2021).

Fase II: Implementación del Protocolo P.A.S. y Soporte Vital La capacitación se dividió en módulos de intervención crítica siguiendo la normativa de atención prehospitalaria:

Protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer): Se instruyó sobre la evaluación primaria de la escena para garantizar la seguridad del auxiliador y la víctima, evitando que un accidente se convierta en una catástrofe mayor (Cruz Roja Española, 2022).

Manejo de la Obstrucción de Vía Aérea (OVACE): Se realizó la demostración técnica de la Maniobra de Heimlich. Según Merchant et al. (2020), el posicionamiento anatómico correcto y la presión subdiafragmática son determinantes para lograr una desobstrucción efectiva sin causar lesiones internas.

Técnicas de Soporte Vital Básico (SVB): Se enfatizó en la ejecución de compresiones torácicas de alta calidad. La normativa técnica exige una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad de al menos 5 cm para mantener la perfusión orgánica vital (AHA, 2020).

Fase III: Simulación Clínica y Retroalimentación Se establecieron estaciones de destreza donde los 30 estudiantes aplicaron los conocimientos adquiridos mediante simulacros controlados. Esta fase permitió la corrección de errores de postura y técnica en tiempo real. Como señalan estudios sobre educación médica, la simulación clínica es la herramienta más eficaz para

que el estudiante adquiera la competencia necesaria para estabilizar a un paciente mientras arriba el servicio médico especializado (Ortega & Martínez, 2023).

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Encuesta de Conocimientos: Primeros Auxilios Básicos

1. ¿Ha recibido capacitación o cursos de primeros auxilios anteriormente?

A) Sí

B) No

2. ¿Cuenta con un botiquín de primeros auxilios en su hogar o vehículo?

A) Sí, completo.

B) Sí, pero incompleto.

C) No tengo botiquín.

3. Ante una quemadura, ¿cuál es la primera acción que debe realizar?

A) Aplicar pasta dental o aceite.

B) Enfriar con agua corriente de la llave.

C) Reventar las ampollas que aparezcan.

4. ¿Cuál es el número de teléfono de emergencias en su localidad?

A) Lo conozco correctamente.

B) No lo conozco o tengo dudas.

5. Si una persona se está atragantando y no puede respirar ni toser, ¿qué hace?

A) Darle un vaso de agua o pan.

B) Realizar la Maniobra de Heimlich (compresiones abdominales).

C) Esperar a que el objeto baje solo.

6. En caso de una hemorragia (sangrado abundante), ¿qué es lo más efectivo?

A) Aplicar presión directa sobre la herida con un paño limpio.

B) Echar alcohol directamente en la herida abierta.

C) No tocar la herida por riesgo a infección.

7. ¿Cuál es el orden correcto de los pasos a seguir en una emergencia?

A) Socorrer, Avisar y Proteger.

B) Proteger, Avisar y Socorrer (Conducta PAS).

C) Avisar, Socorrer y Proteger.

8. Si alguien sufre un desmayo, ¿qué posición es la más adecuada?

A) Sentarlo y darle agua.

B) Acostarlo y elevar sus piernas ligeramente.

C) Dejarlo de pie y abanicarlo.

9. ¿Sabe usted cómo realizar las compresiones para RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)?

A) Sí, lo he practicado.

B) Conozco la teoría, pero no lo he practicado.

C) No sé cómo se hace.

10. ¿Qué tan importante considera que es saber primeros auxilios para la población general?

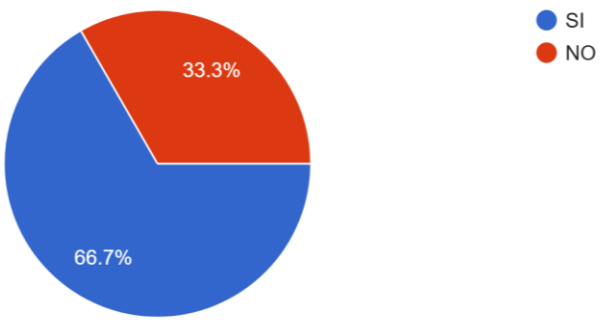
A) Muy importante.

B) Poco importante.

C) Nada importante.

Gráfico 1

Formación previa en protocolos de asistencia y primeros auxilios



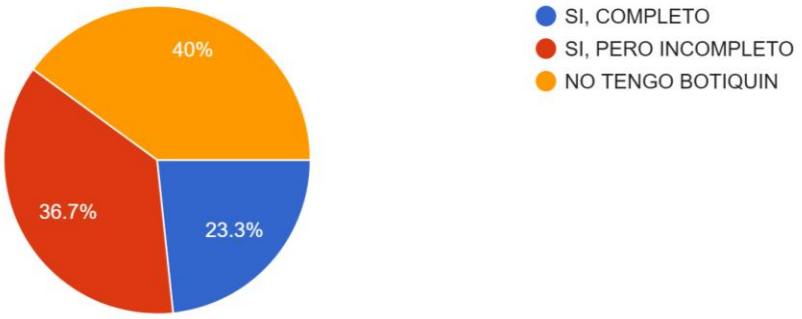
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se determinó que el 66.7% de los estudiantes ha recibido instrucción o capacitación técnica en primeros auxilios con anterioridad. En contraste, un 33.3% manifiesta carecer de formación en esta área, lo que representa a una tercera parte de la muestra sin los conocimientos básicos para responder ante emergencias médicas. Estos resultados sugieren una base de preparación favorable en la mayoría del grupo, aunque subrayan la necesidad de implementar talleres de actualización para garantizar que la totalidad de los individuos cuente con herramientas de respuesta inmediata.

Gráfico 2

Disponibilidad de insumos médicos básicos en el entorno personal



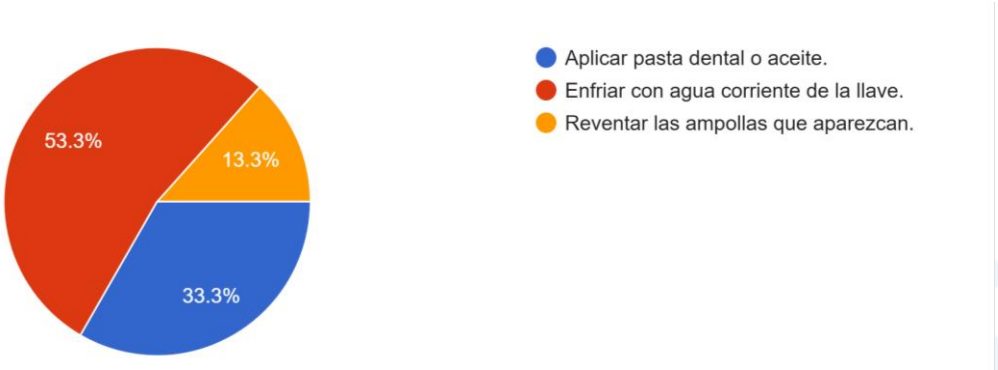
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se constató que un 40% de los encuestados carece de un botiquín de primeros auxilios en su hogar o vehículo. Por otro lado, un 36.7% cuenta con este recurso, aunque admite que se encuentra incompleto, dejando apenas a un 23.3% con el equipamiento reglamentario total para una atención inmediata. Estos resultados revelan una desprotección material significativa en la mayoría de la muestra; a pesar de que el estudio previo mostró que un alto porcentaje tiene capacitación teórica, la falta de suministros físicos limita su capacidad real de respuesta ante incidentes imprevistos.

Gráfico 3

Nivel de conocimiento sobre protocolos de respuesta ante quemaduras



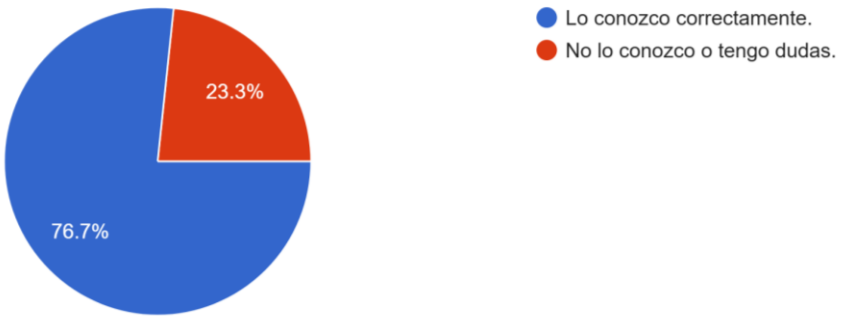
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se determinó que el 53.3% de los participantes identifica correctamente el enfriamiento con agua corriente como la acción inicial ante una quemadura. No obstante, resulta preocupante que un 46.6% acumulado optaría por procedimientos contraindicados, como la aplicación de sustancias caseras (aceite o pasta dental) o la manipulación de ampollas. Estos hallazgos evidencian una persistencia de mitos urbanos en casi la mitad de la muestra, lo que resalta la urgencia de fortalecer la educación sanitaria para prevenir complicaciones derivadas de una mala praxis en la atención de lesiones térmicas.

Gráfico 4

Identificación del contacto telefónico de emergencias locales



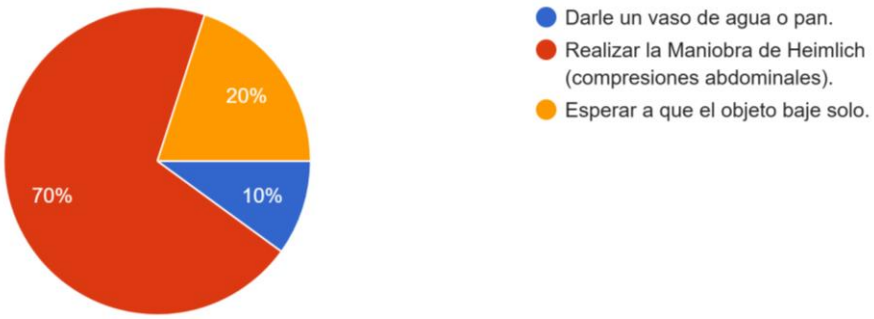
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se determinó que el **76.7%** de los participantes tiene un conocimiento preciso sobre el número de contacto de emergencias de su localidad (911). No obstante, existe un **23.3%** de la muestra que presenta dudas o desconoce esta información vital. Aunque la mayoría de los encuestados está informada, este margen de desconocimiento representa un factor de riesgo crítico, ya que la demora en la solicitud de asistencia profesional puede comprometer el pronóstico de recuperación en situaciones de crisis. Estos datos subrayan la importancia de reforzar las campañas de difusión sobre los canales de atención ciudadana para asegurar una respuesta comunitaria eficiente.

Gráfico 5

Conocimiento técnico sobre maniobras de desobstrucción de la vía aérea



Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se determinó que el 70% de los participantes identifica correctamente la Maniobra de Heimlich como el protocolo de actuación ante un atragantamiento severo. En contraparte, un 20% de la muestra optaría por una conducta pasiva de espera, mientras que el 10% restante aplicaría métodos empíricos contraindicados, como la ingesta de agua o alimentos sólidos. Estos hallazgos demuestran que, aunque existe una noción mayoritaria sobre el procedimiento adecuado, persiste un segmento de la población que recurriría a acciones ineficaces que podrían agravar el cuadro de asfixia, reforzando la necesidad de capacitación práctica en soporte vital básico.

Gráfico 6

Nivel de conocimiento sobre el manejo inicial de hemorragias externas

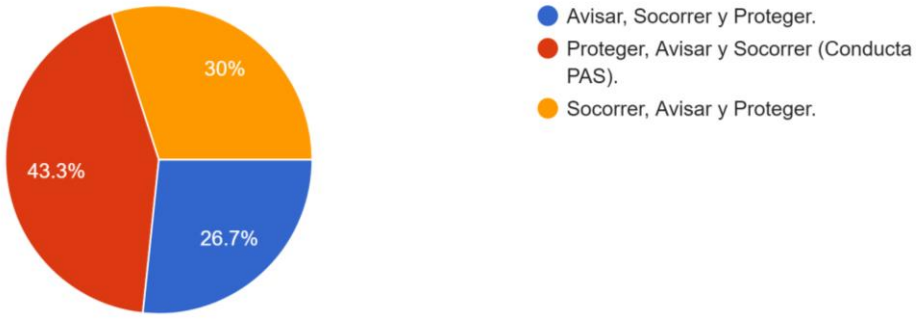
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se constató que el 70% de los individuos evaluados reconoce la aplicación de presión directa con material limpio como la técnica más efectiva para detener un sangrado abundante. No obstante, persiste un 30% de la muestra que optaría por métodos erróneos, ya sea por omisión de auxilio ante el temor a infecciones (16.7%) o por el uso de sustancias irritantes como alcohol sobre heridas abiertas (13.3%). Estos hallazgos revelan que, si bien la mayoría posee una noción básica de primeros auxilios, existe un grupo considerable que aplicaría medidas perjudiciales, lo que resalta la importancia de corregir mitos sobre el cuidado de heridas para evitar daños secundarios en el tejido afectado.

Gráfico 7

Conocimiento de la secuencia protocolaria ante una emergencia (Conducta PAS)



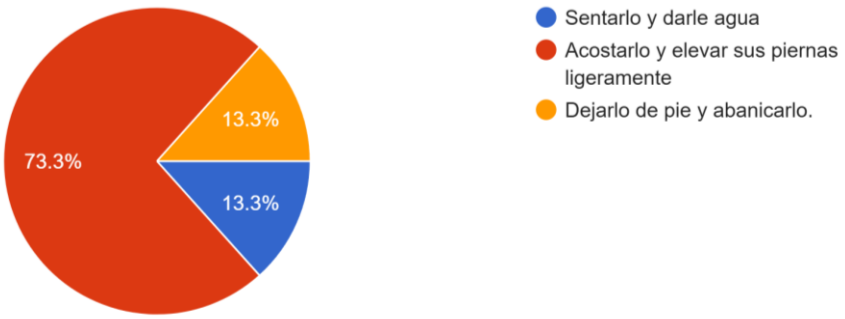
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se determinó que el 43.3% de los participantes identifica correctamente la Conducta PAS (Proteger, Avisar y Socorrer) como el orden jerárquico a seguir ante un incidente. No obstante, existe una fragmentación preocupante en el conocimiento, ya que el 56.7% restante optaría por secuencias invertidas que priorizan el socorro antes que la seguridad de la escena o el aviso a profesionales. Estos hallazgos sugieren que, si bien una parte considerable de la muestra posee nociones teóricas, prevalece una confusión operativa que podría comprometer la integridad tanto del auxiliador como de la víctima al no asegurar el entorno antes de intervenir.

Gráfico 8

Conocimiento sobre la postura terapéutica ante cuadros de lipotimia o desmayo



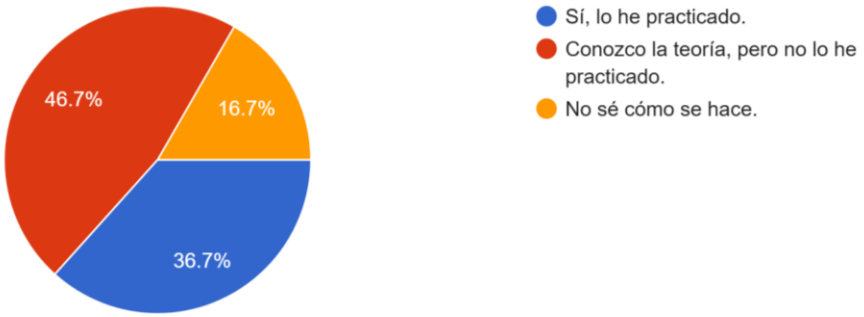
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se constató que el 73.3% de la muestra identifica correctamente que acostar a la persona y elevar sus extremidades inferiores es la posición más adecuada para favorecer el retorno venoso y la recuperación. No obstante, un 26.7% acumulado optaría por medidas ineficaces o potencialmente peligrosas, como sentar a la víctima y darle agua o dejarla de pie. Estos resultados indican que, aunque la mayoría conoce el protocolo básico de reanimación posicional, aún persiste una cuarta parte de la población que aplicaría maniobras erróneas que podrían retrasar la recuperación del estado de conciencia o provocar accidentes adicionales.

Gráfico 9

Capacidad operativa para la ejecución de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)



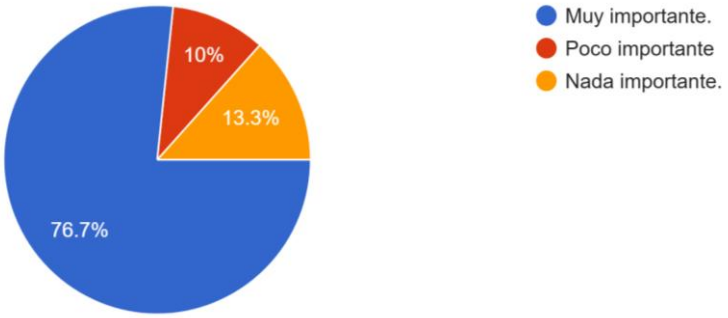
Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se identificó que el 36.7% de los encuestados ha practicado previamente las maniobras de compresión torácica, lo que sugiere una base operativa capacitada dentro del grupo. No obstante, la mayor parte de la muestra (46.7%) posee únicamente conocimientos teóricos sin experiencia práctica, mientras que un 16.7% admite desconocer totalmente el procedimiento. Esta brecha entre la teoría y la práctica es crítica, ya que la efectividad de la RCP depende de la destreza motriz y la confianza adquirida en simulacros, resaltando la necesidad de capacitaciones presenciales para transformar el conocimiento pasivo en una respuesta efectiva.

Gráfico 10

Percepción social sobre la importancia de la capacitación en primeros auxilios en la población general.



Nota: Elaboración propia

Análisis:

Se identificó que una mayoría predominante del 76.7% de los encuestados considera fundamental el dominio de técnicas de asistencia inicial, lo que refleja una sólida conciencia sobre la responsabilidad civil ante emergencias. No obstante, existe un sector del 13.3% que califica estos conocimientos como carentes de importancia, sumado a un 10% que los percibe como poco trascendentes para la población.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.

Los resultados obtenidos evidencian que, si bien una parte considerable de los estudiantes demuestra conocimientos generales sobre primeros auxilios básicos, persisten deficiencias significativas en temas fundamentales como la secuencia correcta de la conducta PAS, la ejecución técnica de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el manejo adecuado de quemaduras y hemorragias. Esta situación es relevante desde el punto de vista sanitario, ya que en una emergencia real la aplicación incorrecta de maniobras puede agravar el estado del individuo o retrasar la activación del sistema de emergencias. Por lo tanto, el nivel de conocimiento identificado no garantiza una respuesta completamente segura ni efectiva ante eventos críticos dentro del entorno escolar.

La mayoría de los estudiantes reconoce que los primeros auxilios son muy importantes para la población; sin embargo, los resultados demuestran que esta percepción positiva no se traduce necesariamente en un dominio técnico adecuado.

Se identificó que un porcentaje significativo presenta dudas o errores conceptuales en situaciones específicas, lo que evidencia que la conciencia sobre la importancia del tema no siempre está acompañada de una preparación práctica suficiente. Esta brecha entre valoración y competencia representa un punto crítico que debe ser atendido desde la educación preventiva.

El diagnóstico realizado permite concluir que no existe una preparación uniforme en primeros auxilios básicos entre los estudiantes de 3.º año de Bachillerato de la Unidad Educativa Simón Bolívar.

Considerando que el entorno escolar es un espacio donde pueden ocurrir accidentes, actividades deportivas, desmayos o situaciones de emergencia súbita, la falta de conocimientos sólidos y estandarizados podría comprometer la seguridad tanto del estudiante afectado como de quien intenta ayudar.

Desde una perspectiva de salud pública y prevención primaria, estos hallazgos evidencian la necesidad de implementar estrategias educativas que fortalezcan la capacidad de respuesta inmediata en la comunidad estudiantil.

Recomendaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda que la Unidad Educativa Simón Bolívar implemente un programa estructurado de capacitación en primeros auxilios dirigido a los estudiantes de Bachillerato. Esta formación debería incluir componentes teóricos y prácticos, especialmente en temas críticos como la conducta PAS, el manejo de hemorragias, quemaduras, desmayos y reanimación cardiopulmonar (RCP), con el fin de reducir las brechas de conocimiento identificadas en la evaluación.

Se sugiere integrar de manera progresiva contenidos básicos de atención prehospitalaria y prevención de riesgos en las actividades académicas o proyectos transversales de la institución.

Esto permitiría que los estudiantes desarrollen competencias básicas de respuesta ante emergencias como parte de su formación integral.

Se recomienda efectuar evaluaciones diagnósticas periódicas para monitorear el nivel de preparación de los estudiantes y medir posibles avances en caso de implementarse capacitaciones futuras. Esto permitirá establecer estrategias basadas en evidencia y mejorar la seguridad dentro del entorno escolar.

Dado que el conocimiento debe ir acompañado de recursos adecuados, se recomienda verificar que la institución cuente con botiquines completos, accesibles y correctamente señalizados, además de personal responsable de su mantenimiento y supervisión.

ANEXOS

REFERENCIAS

Alexandra, V., & Esparza, A. (2018). Importancia de los conocimientos de los primeros auxilios básicos para los estudiantes de enfermería. *Opuntia Brava*, *10*(1), 79-89. https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/57

bibliográfica Alumno, R., San Millán, F., Tutor, R., & Crespo Brunet, E. (2016). *Estudio crítico de la maniobra de Heimlich en la asfixia por atragantamiento*. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/35271

Delgado, B., Dominique, D., General Rumiñahui, A., -Ecuador, S., Panchi, C., Valeria, D., Salazar, P., Tatiana, K., Pinos, P., Leonardo, R., Guano, R., & Belén, M. (2021). *EL DIAGRAMA DE ISHIKAWA COMO HERRAMIENTA DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN: UNA REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS THE ISHIKAWA DIAGRAM AS A QUALITY TOOL IN EDUCATION. A REVIEW OF THE LAST 7 YEARS: LITERATURE REVIEW*. *14*(84), 1212-1230. https://tambara.org/wp- content/uploads/2021/04/DIAGRAMA-ISHIKAWA_FINAL-PDF.pdf

Flouris, A. D., & Schlader, Z. J. (2015). Human behavioral thermoregulation during exercise in the heat. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, *25*(S1), 52-64. https://doi.org/10.1111/SMS.12349

Maldonado, T., Calero, F. E. E., Vicente, G., Méndez, M., Jhann, H., Albán, S., Vanessa, J., & Pacheco, R. (2017). Tratamiento en heridas de piel. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento, ISSN-e 2588-073X, Vol. 1, Nº. 4, 2017, págs. 577-609, 1*(4), 577-609. https://doi.org/10.26820/recimundo/1.4.2017.577-609

Palma La Juventud, E. DE, & Suley Idrogo Benavides, G. (2022). La importancia de los primeros auxilios en la tradición «Hilachas». *El Palma de la Juventud*, *4*(4), 129-142. https://doi.org/10.31381/EPDLJ.V4I4.4899

Pancorbo-Hidalgo, P. L. (2016). Investigación sobre las heridas. *Gerokomos*, *27*(3), 89-90. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2016000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Tenorio, D., Marino Escobar, J., Garzón, E. S., Castaño, C., Acevedo, A., & Martínez, J. W. (2009). Efectividad de Intervenciones Educativas en Primeros Auxilios. *Investigaciones Andina*, *11*(18), 81-91. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81462009000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Villalón, M., Salas, E., & Lucena, I. (2005). Traumatismo oro-facial por mordedura canina. Presentación de un caso clínico Oro-Facial Trauma Caused by Dog Bites. A Case Report. *ciencia odontológica*, *2*(1), 84-97. https://www.redalyc.org/pdf/2052/205217240008.pdf

American Heart Association [AHA]. (2020). *Aspectos destacados de las Guías de la American Heart Association de 2020 para RCP y ACE*. https://cpr.heart.org/

Cruz Roja Española. (2022). *Manual de Primeros Auxilios Básicos*. Editorial Planeta.

Merchant, R. M., Topjian, A. A., & Panchal, A. R. (2020). Part 1: Executive Summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 142(16), S337–S357.

Ortega, J., & Martínez, L. (2023). *La simulación como estrategia de aprendizaje en primeros auxilios*. Revista de Educación Médica y Salud, 12(2), 45-58.

Pérez, G., Santos, M., & Ramírez, F. (2021). *Primer interviniente: La clave en la urgencia prehospitalaria*. Editorial Médica Panamericana.